GUIÓN — Presentación Final (versión venta)

Proyecto HELIOS · Cierre del ProyectoReparto: Marian → Ethan → José → Alejandro → Ashley → Marian

---

MARIAN — Slide 1 (Portada + gancho, 20s)

"Buenas, profesora y compañeros. Somos el Grupo HELIOS. En Panamá, agendar una cita en una policlínica todavía significa llamar, esperar, o hacer fila. Nosotros construimos un sistema que lo resuelve: agendar, cancelar, reprogramar y recibir notificación — todo en menos de 2 minutos, desde el celular. Hoy no les vamos a contar solo cómo lo construimos. Se los vamos a mostrar funcionando, y les vamos a contar qué dijo un médico real que lo probó."

ETHAN — Slide 2 (Demo en vivo, primero, 60s)

"Empezamos por lo más importante: verlo funcionar.

helios-web-production.up.railway.app

[Demo en vivo: registrar paciente → agendar cita → campanita + correo llegan solos]

Lo que acaban de ver no tiene truco: no recargamos la página, no revisamos nada manualmente. El sistema avisó solo, en segundos, tanto dentro de la web como al correo. Le paso a José con lo que más nos importa mostrarles hoy."

JOSÉ — Slide 3 (Validación real: feedback del médico, 60s)

"Todo lo que acaban de ver lo construimos nosotros. Pero lo que de verdad valida un producto de salud es que alguien ajeno al equipo lo use y opine con criterio clínico. Por eso llevamos HELIOS a un médico que trabaja en salud pública, en una policlínica — su experiencia es exactamente el contexto real para el que diseñamos este sistema. Fue una prueba guiada, sin pacientes ni consultas reales de por medio, solo para que lo evaluara con ojo profesional.

Su reacción fue clara: le pareció increíble, y destacó algo que no esperábamos que notara — el estilo visual y los colores estaban muy bien logrados. En salud eso importa más de lo que parece: un sistema que se ve confuso genera desconfianza en el paciente antes de que use una sola función.

Pero lo más valioso no fue el elogio — fue su recomendación. Sugirió establecer un máximo de 15 pacientes por día por médico, basado en su propia experiencia gestionando consultas reales. Esa cifra no salió de nosotros, salió de alguien que vive ese problema todos los días. Y es exactamente el tipo de retroalimentación que buscábamos: no que nos digan que se ve bien, sino que nos digan qué le falta para funcionar en la vida real."

ALEJANDRO — Slide 4 (De la recomendación al roadmap, 45s)

"Con esa recomendación del médico, no nos quedamos solo en el elogio. La convertimos en la siguiente prioridad de HELIOS: un límite diario de citas por médico, configurable por sede. La estructura en la base de datos ya está lista para soportarlo — es el primer punto de nuestro roadmap inmediato, justamente porque salió de alguien que conoce el problema desde adentro, no de una suposición nuestra.

Y algo que sí está funcionando hoy, no en el roadmap: el envío de notificaciones — campanita y correo — ya corre de forma completamente autónoma. Nadie del equipo tiene que revisarlo, reiniciarlo, ni tenerlo corriendo en su laptop durante la demo. Eso, para un sistema de salud, no es un detalle — es lo que separa un proyecto de clase de algo que podría sostenerse solo."

ASHLEY — Slide 5 (Calidad, condensado, 30s)

"Para que sepan que esto no es solo una demo bien montada: más de 120 pruebas automáticas corren en cada cambio, con un umbral de cobertura que rechaza el código si baja de 60%. Usamos SonarCloud para calidad de código y Supabase con seguridad a nivel de fila, para que cada paciente y cada médico solo vea lo suyo. Lo construimos con la misma disciplina con la que lo estamos presentando."

MARIAN — Slide 6 (Cierre, 30s)

"HELIOS ya no es un ejercicio de clase — es un sistema desplegado, probado por alguien ajeno al equipo, y funcionando de forma autónoma. Construimos algo que resuelve un problema real en Panamá: que agendar una cita médica no debería tomar más de dos minutos.

Pueden probarlo ustedes mismos ahora mismo en el link. ¿Preguntas?"

Qué se cortó del guion original y por qué

Del guion original	Qué se hizo
Slide "Del plan a la práctica" (retro completa)	Eliminada — nadie compra un producto por su retrospectiva interna
GLAD / MAD / SAD detallados (3 slides)	Reducidos a una frase dentro del cierre de Alejandro, ya no ocupan slides propias
TMMi + TQM completo	Eliminado — sostiene nota de QA, no vende producto
Bloqueos de exámenes finales	Eliminado — es información interna del equipo, no le importa a quien evalúa el producto
Daily Scrum de 3 preguntas	Eliminado como sección — ya queda respondido implícitamente por el demo + la validación
Métricas ISTQB extensas	Reducidas a 2 líneas dentro de la slide de Ashley

Resultado: 6 slides en vez de 12, con la demo y el feedback del médico ocupando el lugar que antes tenía la retrospectiva. Eso es lo que realmente se sostiene si alguien pregunta "¿esto funciona de verdad?" — la respuesta ya no es "seguimos Scrum correctamente", es "un médico real lo probó, y su recomendación ya es nuestra próxima prioridad."
